SmartHealth — playbook utilisateur

Manuel de terrain pour les equipes qui utilisent la plateforme en etablissement. · Oct 27, 2026

À qui s'adresse ce document

Aux équipes qui utilisent SmartHealth en poste : accueil, triage, soignants, caisse, pharmacie, laboratoire, bloc opératoire, direction.

Ne le lisez pas en entier. Chaque poste a sa section ; allez directement à la vôtre. Deux sections, en revanche, valent pour tout le monde et tiennent en deux pages :

- **Les règles qui ne plient jamais** — ce que l'application refusera toujours, et pourquoi. Les connaître évite de chercher un contournement qui n'existe pas.
- **Lire un refus** — un refus n'est pas une panne. C'est une consigne. Savoir le lire fait gagner le temps qu'on passerait au téléphone.

Ce que ce document n'est pas

Il ne remplace pas les protocoles de soins de votre établissement. Il dit comment l'outil se comporte, pas ce qu'il faut prescrire. Quand les deux semblent se contredire, c'est votre protocole qui tranche — et c'est un point à remonter à votre référent, parce que l'outil est censé le servir, pas l'inverse.

Il ne dit pas non plus comment installer la plateforme : cela se trouve dans le dossier d'installation, destiné au responsable technique.

Les règles qui ne plient jamais

Six règles ne cèdent devant aucun bouton, aucun rôle, aucune urgence. Elles ne sont pas des préférences de réglage : elles sont la raison d'être de l'outil.

La règle	Ce qu'elle empêche
Un lit ne porte qu'un patient	Un brancard dans un couloir à trois heures du matin — ou pire, un acte pratiqué sur la mauvaise personne
Une urgence vitale ne passe jamais derrière un cas moins grave	Qu'une file strictement chronologique laisse mourir quelqu'un dans la salle d'attente

La règle	Ce qu'elle empêche
L'argent ne barre pas la route d'un soin urgent	Qu'une prise en charge soit retardée un soir de garde pour une somme dérisoire
Un lot périmé ne sort pas	Un traitement qui échoue pendant qu'on croit traiter — un antibiotique périmé n'est pas moins efficace, il ne marche pas
Une valeur critique est acquittée par quelqu'un de nommé	Qu'une kaliémie à 7 dorme dans une liste que personne n'a ouverte
On n'incise pas sans time out	Qu'on opère le mauvais côté, ou la mauvaise personne

Trois principes qui gouvernent tout le reste

L'application refuse plutôt qu'elle n'avertit. Un avertissement qu'on peut fermer se ferme, et finit par se fermer sans être lu. Quand quelque chose est dangereux, le bouton ne passe pas.

Un refus nomme toujours son remède. Jamais « opération impossible » tout court. Vous lirez ce qui s'y oppose **et** ce qu'il faut faire. C'est fait pour que vous agissiez sans appeler l'informatique.

Elle s'abstient plutôt que d'inventer. Ce qui n'a pas été dit ne sera pas rempli. Un résultat sans seuil configuré est rendu « non interprété », et non « normal » : affirmer une absence de danger que personne n'a établie serait pire que de ne rien dire.

Une seule exception, assumée

La caisse **avertit** au lieu de refuser sur les actes vitaux et urgents. C'est voulu, et c'est le seul endroit : une facture impayée se recouvre, une prise en charge retardée ne se rattrape pas.

Lire un refus

Un refus arrive toujours sous la même forme : **ce qui s'y oppose**, puis **ce qu'il faut faire**. La seconde ligne est celle qui compte — lisez-la avant de rappeler qui que ce soit.

> **L'exemple à retenir** « Le lit MED-12-A est occupé par un autre patient. » « Choisir un lit libre, ou sortir ou transférer son occupant avant. »

Si un refus vous paraît absurde, il dit presque toujours que **l'état réel n'est pas celui que vous croyez** : quelqu'un d'autre est passé avant vous. Rafraîchissez l'écran : la liste se remet à jour toute seule après un refus, justement pour ça.

Les refus que vous rencontrerez le plus

Ce que l'écran dit	Ce que ça veut dire	Ce que vous faites
Le lit est occupé par un autre patient	Un séjour en cours déclare ce lit, même si le plan l'affiche libre	Choisir un autre lit, ou sortir l'occupant
Le lit a été libéré mais n'est pas encore préparé	Le nettoyage n'a pas été enregistré	Le marquer préparé une fois le ménage fait, puis recommencer
Ce patient attend déjà à un autre poste	Il ne peut pas être dans deux files à la fois	Le retirer de l'autre file, ou terminer son passage
Le montant dépasse le reste à charge	On vous tend plus que ce qui est dû	Encaisser le montant indiqué, rendre la différence
Tous les lots en rayon sont périmés	Il reste du stock, mais il est inutilisable	Retirer les boîtes du rayon, mettre en destruction, commander en urgence
Le dossier signale une allergie	Le patient a déjà réagi à cette substance	Revenir vers le prescripteur. **Jamais sur avis téléphonique seul**
L'identité annoncée ne correspond pas au dossier	Nom ou date de naissance divergent	**Ne pas prélever.** Reprendre l'identité avec le patient
Checklist « avant incision » incomplète	Le time out n'est pas fait	Le refus liste les points manquants, un par un
Le nom du soignant prévenu est requis	Vous acquittez sans dire qui a été joint	Écrire le nom. Un acquittement anonyme n'acquitte rien

Ce qu'un refus n'est pas

Ce n'est pas un bogue, et ça ne se contourne pas en recommençant. Si vous vous surprenez à chercher un détour — une autre fiche, un autre écran — arrêtez-vous : c'est exactement la situation que la règle empêche. Remontez le cas à votre référent plutôt que de le forcer.

Accueil, triage et files d'attente

Votre écran : Lits et files → la file de votre poste.

Placer un patient dans une file

Le patient doit d'abord être **présent** dans l'établissement — un séjour ouvert, même externe. Sinon l'application refuse : « L'admettre d'abord, puis le placer dans la file. »

La gravité est obligatoire et n'a pas de valeur par défaut. C'est volontaire : un défaut « standard » transformerait chaque saisie pressée en sous-triage silencieux, et le sous-triage est exactement ce qu'une file est censée rattraper.

Gravité	Quand
Vitale	Le pronostic vital est engagé maintenant
Urgente	La prise en charge ne peut pas attendre la fin de la matinée
Standard	Consultation ordinaire
Differable	Peut attendre sans dommage

Comment l'ordre est calculé

D'abord la gravité, puis l'ancienneté. Un patient qui attend depuis plus de **90 minutes** remonte d'un cran et porte la mention « remonte ».

Ce cran ne franchit jamais le niveau vital. Un cas « differable » qui attend depuis trois heures passera devant les standards arrivés après lui — jamais devant une urgence vitale qui vient d'entrer.

Les trois gestes

- **Appeler** — le patient quitte la file et passe en prise en charge. Si vous le rappelez, l'application le dit : il est déjà pris en charge.
- **Terminer** — le passage est clos, le patient peut être orienté ailleurs.
- **Parti** — le patient a quitté la file **sans avoir été vu**.

> **« Parti » n'est pas « terminé », et la différence compte.** La part de patients qui repartent avant d'être appelés est le seul indicateur qui compte des **gens** plutôt que des actes. C'est le chiffre sur lequel une direction ouvre un poste de renfort. Les enregistrer comme « terminés » les fait disparaître des tableaux au moment précis où le poste est le plus saturé.

Ce que vous lisez sur le tableau de bord

Attente médiane : ce que vit la majorité. **Attente maximale** : qui est oublié. Les deux ensemble, pas l'une sans l'autre — une médiane correcte masque très bien quelqu'un qui attend depuis quatre heures.

La consultation et la dictée

Votre écran : Consultations → la consultation en cours.

Avant de dicter

L'enregistrement suppose le **consentement du patient**. Dites-lui ce que vous faites — la case n'est pas une formalité, c'est la seule chose qui rend l'écoute légitime.

Trois moteurs de transcription peuvent être disponibles selon l'installation. Celui qui tourne **sur l'appareil** ne fait sortir aucun octet d'audio ; c'est celui à préférer dès qu'il est là.

Pendant la dictée

Parlez normalement. L'application découpe aux silences et transcrit tour de parole par tour de parole. Elle s'adapte au bruit de la pièce : un ventilateur ou une cour bruyante ne l'empêchent plus de repérer les silences.

Chaque tour est attribué — médecin, patient, accompagnant — avec un degré de certitude. Les tours dont elle n'est pas sûre sont marqués **indéterminés** plutôt que devinés. Un tour indéterminé n'est pas une panne : c'est l'application qui refuse de vous faire confiance à sa place.

Après la dictée : c'est vous qui validez

Rien n'entre au dossier sans vous. L'analyse **propose** ; vous relisez et vous signez.

- Chaque élément extrait renvoie à **la phrase qui le justifie**. Si vous ne retrouvez pas la phrase, c'est que l'élément ne tient pas — retirez-le.

- Les champs pour lesquels rien n'a été dit **restent vides**. Un vide est une information : il dit que la question n'a pas été posée.
- Les alertes de sécurité — allergie, interaction, posologie pédiatrique — s'affichent **avant** la signature.

Corriger un mot mal transcrit

Corrigez-le dans le validateur, simplement. L'application retient la correction comme une **leçon** et l'applique aux dictées suivantes, sans qu'on redémarre quoi que ce soit.

Deux garde-fous, qu'il vaut mieux connaître :

- Une leçon n'est appliquée qu'à partir de **deux consultations distinctes**. Une correction isolée peut être une faute de frappe, et une leçon retenue à tort abîmerait en silence tout ce qui suit.
- Elle n'apprend que des **mots mal entendus**, pas des reformulations. Réécrire une phrase pour qu'elle sonne mieux n'apprend rien à la machine — et c'est voulu.

Les leçons retenues sont consultables sur l'écran **Corrections apprises**, et révocables une par une.

La caisse

Votre écran : le séjour du patient → Ouvrir la caisse.

L'avis avant un acte : lisez le ton, pas seulement le montant

C'est le seul endroit de la plateforme où l'application **avertit** au lieu de refuser. Le ton de l'encadré dépend de l'urgence de l'acte, **pas** de la somme due.

Acte	Ce que vous voyez	Ce que vous faites
Vital ou urgent	Encadré sobre : le reste à charge, puis « l'acte est réalisé, la régularisation se fait après »	**L'acte se fait.** Vous régularisez ensuite
Programmable	Encadré rouge, bloquant	L'acte attend le règlement, ou l'arbitrage d'un responsable

> Si vous vous surprenez à faire patienter quelqu'un pour une somme alors que son acte est urgent, **relisez l'encadré** : il dit le contraire. Une facture impayée se recouvre ; une prise en charge retardée ne se rattrape pas.

Encaisser

Les montants sont en **francs entiers**. Pas de centimes : une caisse qui dérive d'un centime par ligne finit par ne plus tomber juste.

- **On ne vous laisse pas encaisser plus que le reste à charge.** Le refus donne le montant exact à prendre et vous dit de rendre la différence. L'application ne décide pas seule qu'un patient vient de faire un don.
- **Un paiement ne se modifie ni ne se supprime.** Il n'y a ni bouton Modifier ni bouton Supprimer, et ce n'est pas un oubli : une caisse dont les lignes s'éditent ne prouve rien, et c'est une preuve qu'on lui demande. Une erreur se corrige par un mouvement inverse, tracé comme tel.
- **Mobile money** : saisissez la référence de transaction. C'est elle qui permettra de retrouver l'opération dans six mois.

Le trop-perçu

Quand une mutuelle accorde sa prise en charge **après** que le patient a payé, l'argent versé devient en trop. L'écran l'affiche en clair : « X F perçus en trop. À rembourser. »

Ce n'est pas une recette. Une caisse qui avale un trop-perçu en silence transforme une erreur de rendu en produit.

Clore une facture

Une facture **non soldée ne se clot pas**. Le refus nomme ce qu'il reste. Sinon la créance resterait due sans plus apparaître nulle part — c'est-à-dire perdue.

La pharmacie

Votre écran : Pharmacie.

Lire le rayon

Les références qui demandent une action sont **en tête**, pas par ordre alphabétique. Quatre états :

État	Ce que ça veut dire	Ce qu'on fait
Périmé	Il reste du stock, il est inutilisable	Retirer du rayon, mettre en destruction, commander
Rupture	Aucune unité servable	Commander, prévenir le prescripteur

État	Ce que ça veut dire	Ce qu'on fait
Stock bas	Au seuil ou en dessous	Commander maintenant, pas demain
Suffisant	Rien à faire	—

Deux colonnes sont volontairement séparées. **Périmé** est une perte déjà consommée. **Bientôt** — moins de 30 jours — est le seul chiffre sur lequel on peut encore agir : écouler en priorité, ou transférer vers un centre qui en consomme davantage.

Dispenser

L'application choisit le lot pour vous : **celui qui périme le plus tôt**, pas le plus ancien ni le plus gros. Un lot reçu récemment mais proche de sa date part avant un vieux lot à longue péremption — sinon il se périme en rayon pendant qu'on sert l'autre.

Le numéro de lot est **recopié sur la ligne de dispensation**, pas seulement référencé. Le jour où un rappel de lot tombe — des années plus tard — la question « qui a reçu ce lot » a une réponse immédiate.

Les trois refus que vous rencontrerez

Lot périmé. « Tous les lots en rayon sont périmés. » Il n'y a pas de dérogation, même s'il ne reste que ça, même la nuit. Un antibiotique périmé n'est pas moins efficace : c'est un traitement qui échoue pendant qu'on croit traiter.

Allergie. « Le dossier signale une allergie à … » — retour au prescripteur pour une alternative. **Jamais sur avis téléphonique seul.** Le contrôle est volontairement large : il déclenche aussi sur les classes portées en suffixe, par exemple une allergie aux thiazides face à un hydrochlorothiazide.

> Ce que le contrôle **ne** couvre **pas** : les allergies croisées entre substances aux noms différents. Une allergie à la pénicilline ne déclenche pas sur l'amoxicilline. Le contrôle à la prescription reste le filet principal — celui-ci est le dernier, pas le seul.

Stock insuffisant. Par défaut l'application **refuse** de servir moins que demandé, en chiffrant ce qui manque. La dispensation partielle existe, mais elle doit être un **choix explicite** de votre part : servir trois comprimés sur vingt en silence renvoie le patient avec un traitement incomplet qu'il croit complet.

Quand vous l'acceptez, **notez-le sur l'ordonnance**. Le patient doit savoir qu'il lui manque quelque chose.

Laboratoire et imagerie

Votre écran : Laboratoire.

Le prélèvement : l'identité d'abord

L'application vous demande le **nom et la date de naissance tels que le patient les annonce**. Le champ est vide à dessein : il ne doit pas être recopié de l'écran.

> Un contrôle d'identité rempli depuis l'écran concordera toujours. Il ne contrôle alors plus rien. Demandez au patient.

La date de naissance accompagne le nom parce que **deux homonymes dans un même service ne sont pas une hypothèse d'école** : c'est l'ordinaire d'une maternité ou d'un service de pédiatrie.

Si ça ne concorde pas : **ne prélevez pas.** Reprenez l'identité avec le patient et vérifiez que vous tenez le bon dossier. Le refus est enregistré au journal — c'est un événement d'identitovigilance, et savoir qu'il a eu lieu vaut plus que le refus lui-même.

L'ordre nom-prénom n'a pas d'importance : « Houngbedji Bernard » et « Bernard Houngbedji » passent tous les deux.

Le délai de stabilité

Certains examens ont une durée au-delà de laquelle l'échantillon ne vaut plus rien. Un tube oublié deux heures sur une paillasse rend une **kaliémie faussée vers le haut** — le potassium sort des hématies. On traiterait une hyperkaliémie qui n'existe pas, sur quelqu'un qui va bien.

L'application refuse alors le rendu : « Ne pas rendre ce résultat : il serait faux dans le sens qui fait traiter. Reprélever. »

Lire une interprétation

Mention	Ce que ça veut dire
Critique	Hors des bornes posées par votre laboratoire. À transmettre maintenant
Normal	Dans les bornes **posées par votre laboratoire**
Non interprété	Aucune borne n'a été configurée pour cet examen

« Non interprété » n'est pas une panne. Les seuils viennent de votre établissement, jamais du logiciel : ils dépendent de la population, de l'automate et de ce que le service sait faire en réponse. Un seuil recopié d'ailleurs engagerait un laboratoire qui ne l'a jamais validé.

La valeur critique : acquitter, c'est nommer quelqu'un

Une valeur critique apparaît **en tête de l'écran, en rouge**, et y reste jusqu'à ce qu'un soignant **nommé** l'ait reçue. Le compteur « critiques non transmises » doit valoir zéro.

Le champ du nom est obligatoire et il n'y a **pas de liste déroulante** : on choisit un nom dans une liste sans avoir décroché le téléphone.

> « Transmis » sans destinataire est exactement ce qu'on retrouve dans les dossiers après un accident : la case est cochée, et personne ne se souvient d'avoir été appelé.

Corriger un résultat

Une correction **crée une nouvelle version** et exige un motif. L'ancienne reste visible, barrée et marquée « remplacée ».

Ce n'est pas de la lourdeur administrative : un clinicien a pu prescrire sur la foi de la première valeur, et l'effacer effacerait aussi la raison de ce qu'il a fait.

Le bloc opératoire

Votre écran : Bloc → le programme du jour → l'intervention.

Le côté, affiché en grand

Sur le programme et sur la fiche, le côté apparaît **en rouge et en majuscules** — DROITE, GAUCHE, BILATERAL. Ce n'est pas une coquetterie : c'est la seule information de cette liste dont une erreur ne se rattrape pas.

Un geste latéralisé **ne peut pas être programmé sans côté**. Il n'y a pas de valeur par défaut, parce qu'un défaut silencieux sur une latéralité est le mécanisme même de l'erreur de côté. L'incohérence inverse est refusée aussi : « appendicectomie gauche » signale une erreur de saisie qu'il vaut mieux lever avant le bloc.

La checklist, en trois temps

Chaque temps se fait **au moment où l'erreur qu'il attrape est encore rattrapable**. Cocher un temps ne complète pas les autres.

Avant induction — 5 points, puis le patient entre en salle Identité confirmée par le patient lui-même · Consentement · Site opératoire marqué · Allergies vérifiées · Matériel d'anesthésie vérifié

Avant incision — le time out — 4 points, puis on incise Chaque membre de l'équipe s'est nommé · **Patient, geste et site confirmés à voix haute par toute l'équipe** · Antibioprophylaxie · Imagerie affichée

Avant sortie de salle — 3 points, puis l'intervention est close Compresses et instruments comptés · Prélèvements étiquetés au nom du patient · Consignes de surveillance transmises

On n'incise pas sans time out

Le bouton **Inciser** reste inactif tant que les quatre points ne sont pas cochés, et le serveur refuse de toute façon — les deux, dans cet ordre.

Quand il refuse, **il nomme les points qui manquent, un par un**. « Checklist incomplète » tout court ferait rouvrir un écran et relire douze lignes, un jour où l'équipe est pressée — c'est ainsi qu'on finit par tout cocher d'un bloc.

> **Il n'y a pas de bouton « tout cocher », et il n'y en aura pas.** Une checklist qui se coche d'un geste ne vérifie rien ; c'est le propre de celles qu'on remplit après coup.

Un point coché par erreur **se décoche**, et c'est tracé. Refuser le décochage pousserait l'équipe à continuer sur une checklist fausse, ce qui est pire qu'une checklist incomplète.

La salle

Une salle ne porte **qu'une intervention à la fois**. Le refus dit qui l'occupe et sur quel créneau. Deux interventions qui se **touchent** — l'une finit à 10 h, l'autre commence à 10 h — passent sans problème : c'est le programme normal d'une salle.

Le séjour : admission, transfert, sortie

Votre écran : Lits et files → Patients présents → le séjour.

Deux types de séjour

Externe — le patient passe, il n'occupe pas de lit. **Hospitalisation** — il reste, il lui faut un lit. L'application refuse de mélanger les deux : un séjour externe avec un lit, ou une hospitalisation sans lit, sont tous deux arrêtés. Le refus propose les deux issues.

> Un patient aux urgences **est présent**, même sans lit. Il apparaît dans « Patients présents », et c'est voulu : l'oublier revient à perdre sa trace entre deux écrans.

Les quatre états d'un lit

État	Ce que ça veut dire
Libre	Prêt à recevoir
Occupé	Un séjour en cours le déclare
À préparer	Libéré, pas encore nettoyé
Hors service	Indisponible

Un lit libéré repasse « à préparer », jamais « libre ». Un lit qui vient d'être occupé n'est pas prêt ; le rendre libre inviterait à y installer le patient suivant avant le nettoyage, et c'est le raccourci qu'un service sous tension prend sans y penser. Marquez-le préparé une fois le ménage fait.

Un lit ne porte qu'un patient

Si le plan affiche un lit libre mais que l'application le refuse, **croyez l'application**. Elle ne regarde pas l'état affiché du lit : elle cherche s'il existe un **séjour en cours** qui le déclare. L'état d'un lit est une donnée dérivée qu'un incident — une coupure, un écran fermé trop vite — peut laisser en arrière. Un séjour qui déclare un lit, lui, fait foi.

Cette règle tient aussi **sous la pression** : deux admissions lancées en même temps depuis deux postes sur le même lit, l'une passe, l'autre est refusée.

Transférer

Seul un patient **présent** se transfère. Le lit quitté repasse « à préparer » automatiquement. Transférer vers le lit qu'il occupe déjà est refusé — c'est en général qu'on s'est trompé de ligne.

Faire sortir

La sortie libère le lit et clot le séjour. Une date de sortie **antérieure à l'admission** est refusée : corrigez celle qui est fausse.

Après la sortie, le séjour est clos. Une nouvelle venue **ouvre un nouveau séjour** — on ne rouvre pas l'ancien, sans quoi deux hospitalisations distinctes se confondraient dans un seul dossier.

Le dossier de séjour

Un seul écran réunit le parcours lit par lit, les consultations rattachées, la file d'attente et la caisse. Un soignant qui doit ouvrir quatre écrans pour savoir où en est un patient finit par n'en ouvrir aucun.

Quand ça se passe mal

L'écran ne dit pas la même chose que le plan mural

Croyez l'écran. L'application ne se fie pas aux états affichés mais aux séjours et aux passages réellement ouverts. Si un lit paraît libre et qu'elle le refuse, c'est qu'un séjour en cours le déclare — trouvez ce séjour avant de forcer quoi que ce soit.

Un refus que je ne comprends pas

Dans la quasi-totalité des cas, **quelqu'un d'autre est passé avant vous** : le patient a été appelé ailleurs, le résultat a été validé, la facture a été close. L'écran se remet à jour tout seul après un refus ; relisez-le avant de réagir.

Coupure de courant, perte de réseau

Sur une installation de poste, l'application et ses données sont **sur la machine**. Une coupure du réseau internet ne l'arrête pas : la transcription embarquée, les dossiers et les écrans hospitaliers continuent.

Ce qui s'arrête : les exports vers des systèmes tiers, et les moteurs de transcription qui tournent sur un serveur distant si votre installation en utilise un.

Après une coupure de courant, **vérifiez les lits « à préparer » et les files** : un geste interrompu en plein milieu a pu ne pas être enregistré. Les mouvements, eux, sont écrits d'un bloc — jamais à moitié.

Je me suis trompé de saisie

Ce que vous avez fait	Ce que vous faites maintenant
Mauvaise gravité dans une file	Terminez le passage et replacez le patient avec la bonne
Mauvais lit à l'admission	Transférez
Paiement erroné	**Ne cherchez pas à le modifier** : il n'y a pas de bouton. Enregistrez un mouvement inverse et signalez-le

Ce que vous avez fait	Ce que vous faites maintenant
Résultat erroné	Déposez une correction avec son motif. L'ancienne version reste, et c'est normal
Point de checklist coché à tort	Décochez-le
Lot périmé servi malgré tout, hors application	Signalez-le immédiatement à votre référent. L'application ne peut pas le rattraper

Je n'ai pas le droit de faire quelque chose

Ce n'est pas un bogue. Les droits sont séparés exprès — voir la section suivante. Si votre poste a réellement besoin de ce droit, c'est votre administrateur d'établissement qui l'accorde, depuis la console, et le changement est tracé.

À qui en parler

Un refus répété qui vous empêche de soigner correctement n'est pas à contourner : c'est à **remonter**. Soit la règle est mal calée pour votre service, soit l'état du dossier est faux — dans les deux cas, quelqu'un doit le savoir.

Qui peut faire quoi

Les droits sont séparés **par poste**, pas par ancienneté ni par grade. Ce n'est pas de la défiance : c'est ce qui rend un inventaire et une caisse opposables, et ce qui protège aussi celui qui soigne.

Rôle	Peut	Ne peut pas
Médecin	Consulter, dicter, signer, prescrire. Appeler son patient suivant. Voir le reste à charge et le stock. Demander des examens, acquitter une valeur critique, opérer	Encaisser. Dispenser. Saisir un résultat d'examen
Établissement	Tous les modules hospitaliers : lits, files, caisse, pharmacie, laboratoire, bloc. Valider les comptes de ses médecins	Administrer la plateforme
Ministère	Indicateurs agrégés, surveillance épidémiologique	**Aucun dossier nominatif**

Rôle	Peut	Ne peut pas
Administrateur	Organisations, comptes, politique de mots de passe, sessions, journal	—

Pourquoi le médecin ne saisit pas de résultat

Ce n'est pas son poste. Confondre les deux retirerait au laboratoire la responsabilité de ce qu'il rend. Il **voit** les résultats, et il **acquitte** ce qu'on lui transmet — c'est l'inverse qui serait étrange.

Pourquoi le médecin n'encaisse pas

Séparer celui qui soigne de celui qui tient la caisse est une règle de contrôle interne élémentaire. Elle protège le médecin autant que l'établissement. Il voit le reste à charge — il doit pouvoir en parler avec le patient et l'orienter — mais il ne touche pas l'argent.

Le cloisonnement, qui n'est pas un droit

Un compte ne voit que les dossiers de **son** établissement. Ce n'est pas une permission qu'on accorde ou qu'on retire : c'est une règle de confidentialité, et elle ne se négocie pas depuis la console.

Tout est journalisé

Chaque accès à un dossier figure au journal, horodaté et nominatif — y compris les refus, comme une discordance d'identité au prélèvement. Ce n'est pas de la surveillance des agents : c'est ce qui permet, le jour où quelque chose s'est mal passé, de reconstituer ce qui a été fait plutôt que de chercher un coupable.